Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de São Joaquim do Monte

Pç. Dr Alberto de Oliveira, S/N, Centro, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE - CEP: 55670-000 - F:(81) 37532970

Processo nº **0000592-91.2022.8.17.3310**

AUTOR(A): ALISSON DA SILVA BEZERRA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 1ª PROCURADORIA REGIONAL - CARUARU

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA tendo por requerente o Sr. ALISSON DA SILVA BEZERRA e no polo passivo o ESTADO DE PERNAMBUCO.

Aduz a inicial que, no ano de 2017, o autor descobriu um tumor na região próxima da orelha esquerda. Em 2018, recebeu diagnóstico de Linfoma, sendo então submetido a cirurgia para retirada do tumor. A partir de então, o autor passou a fazer acompanhamento mensal e bimestral, no Hospital do Câncer, devido à possibilidade de o tumor ressurgir em qualquer outra parte do corpo. Além disso, o autor foi diagnosticado com um tipo específico de inflamação na pele (Dermatite Seborreica e Foliculite de Nuca – CID 10 L21.9 + L66.3) – decorrente de sua baixa imunidade, causada pelo tumor - precisando realizar tratamento para a doença com vários medicamentos e não podendo se submeter por longos períodos à luz do sol. Diante do quadro de saúde do autor, passou a fazer acompanhamento com médico dermatologista, que prescreveu dois medicamentos de uso tópico e contínuo, para controle da inflamação da pele, o shampoo doctar plus e o verutex B creme não podendo ser substituídos por outros genéricos ou fornecidos pelo Estado, em razão da ausência de medicamentos da lista de dispensação obrigatória eficazes para o paciente, assim requereu a concessão da tutela provisória de urgência, ou seja, o fornecimento mensal dos medicamentos retromencionados e, no mérito, a procedência da ação. Decisão deferindo o provimento de urgência e determinando que o Estado de Pernambuco que, no prazo de 10 (dez) dias, fornecesse ao demandante, mensalmente e pelo período necessário, conforme prescrição médica os medicamentos acima

descritos, bem como cominou multa mensal no valor necessário à aquisição dos medicamentos, cujo montante será penhorado via SISBAJUD e entregue em favor da parte autora (ID. 116363340).

Instado a se manifestar o Estado de Pernambuco, apresentou Contestação, alegando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual e que o fornecimento de tratamento segundo nova tese de STF é da União, bem como alegou a ausência de laudo médico circunstanciado acerca da imprescindibilidade do medicamento em detrimento às alternativas terapêuticas do SUS e que há alternativa terapêutica e disponibilizada pelo SUS ao tratamento requestado, além da vedação de vinculação do fármaco pretendido a marca específica. Por fim, requer a improcedência e que em caso de procedência do pedido que seja fixado o prazo razoável para cumprimento da ordem judicial e a avaliação periódica (ID. 117888529).

O Estado de Pernambuco acostou informações acerca das medidas adotadas para fiel cumprimento da liminar deferida no feito epigrafado, ID 120954960 e ID 120954961.

Em réplica a contestação a Defensoria Pública alegou a necessidade de bloqueio de valor na quantia de R$ 472,95 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para cumprimento da liminar, visto que o Estado de Pernambuco ainda não teria cumprido a decisão que concedeu a urgência, alegou ainda que a responsabilidade é solidária entre os entes federados em relação ao direito de saúde, bem como que se necessita da efetiva observância ao princípio da isonomia e a impossibilidade de oposição do princípio da reserva do possível ante o direito mínimo existencial, além da imprescindibilidade do medicamento e da razoabilidade da multa e do prazo fixado para cumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória (ID 127653306).

Decisão em que se manteve a liminar deferida, acolhendo o pedido formulado pela Defensoria Pública e determinando o bloqueio judicial via SISBAJUD da quantia de R$ 472,95 e a expedição do alvará autorizando a parte autora proceder o levantamento do valor, bem como condicionou o deferimento de novos bloqueios à apresentação de relatório e receituário médico circunstanciado que comprovem a evolução do tratamento e necessidade de continuação de uso dos medicamentos (ID 128513572).

O Estado de Pernambuco requereu que esse MM. Juízo enviasse solicitação de informações técnicas ao NATS do TJPE, disponível também aos magistrados federais em razão de acordo de cooperação firmado em dezembro de 2017 entre aquele E. Tribunal e o E. TRF5 (ID. 129695419).

Através da petição de ID 130377019, a Defensoria Pública informou que não tem mais provas a produzir, reiterou os termos da exordial e da réplica e requereu o julgamento antecipado do feito.

Acostada decisão terminativa que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 0002961-75.2022.8.17.9480, em que restou decidido que o prazo é arrazoado quanto a fixação de 10 dias para o fornecimento do tratamento e apenas autorizou ao Estado de Pernambuco solicitar a cada três meses a apresentação de laudo médico atualizado que demonstre a necessidade da continuação do tratamento e seu trânsito em julgado (ID 134267581).

Manifestação Ministerial requerendo novas vistas após a conclusão da produção de provas, ID 140149407.

Despacho determinando a expedição de ofício ao NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SAÚDE (NATJUS) do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que emita o parecer circunstanciado sobre a situação posta, e esclarecendo sobre os medicamentos, devendo responde os questionamentos. Por fim, determinou a intimação das partes para manifestação, após juntada do parecer (ID 141134569).

Despacho determinando que se proceda contato telefônico com o setor responsável Natjus-PE solicitando informações acerca do meio a ser utilizado para a solicitação do parecer técnico, considerando que o sistema desenvolvido pelo CNJ, apresenta indisponibilidade, ID 144025104.

Acostado aos autos parecer emitido através do sistema e-NatJus (ID 161092336).

O Estado de Pernambuco ratificou os termos da contestação, uma vez que as conclusões das notas técnicas corroboram com os argumentos da defesa de que há opções terapêuticas disponíveis no SUS, e cuja eficácia não foi afastada no presente processo (ID 161765950).

A Defensoria Público requereu a procedência dos pedidos formulado na inicial, sob o fundamento de que o laudo médico de ID 116274521 é claro quanto a impossibilidade de substituição dos fármacos solicitados, em razão de que outros genéricos ou disponíveis na farmácia do Estado não seriam eficazes ao caso do paciente (ID 163553885).

Em manifestação de ID. 164877446, o Ministério Público pugnou pelo julgamento procedente do pedido, em confirmação aos efeitos da tutela antecipada, de caráter satisfativo, tudo com fulcro no art. 487, I, CPC, vinculando-se o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica.

É o quanto basta relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A *priori*, destaco que o processo foi instruído sem vícios ou nulidades, atribuindo-se o rito adequado, não havendo falhas a sanar. Assim, está apto à análise de mérito.

Passo ao julgamento antecipado da lide, porque não há necessidade de produção de provas em audiência, na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

De início passo a me pronunciar sobre a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada em sede de peça de defesa.

Ressalto, desde já que, em se tratando de fornecimento de medicamento, como no caso ora em tela, sendo comum o dever de prestar assistência à saúde, a obrigação é solidária, podendo ser exigida de qualquer dos entes federativos, inclusive da Unidade da Federação onde reside o impetrante da ação mandamental, sendo competente, nesse caso, a justiça estadual.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

PASSO A ANÁLISE DO MÉRITO.

Pois bem.

Impende observar, por relevante, que se acham presentes os pressupostos processuais de existência e de validade, e uma vez estabelecida a lide ante a pretensão resistida, em face da dialética processual à vista das alegações das partes litigantes, para correta compreensão da controvérsia, é possível o exercício da Atividade Jurisdicional para resolução do conflito.

Acerca da oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS do TJPE), ressalto que a referida manifestação não é obrigatória, tendo como objetivo oferecer ao julgador fundamentos científicos para decidir pela concessão, ou não, da medicação/tratamento pleiteado. Assim sendo, possui função de apoio técnico e natureza meramente consultiva, sem vincular a decisão do julgador. Porém, em que pese acima destacado observo que, conforme já destacado em relatório houve decisão determinando a expedição de ofício NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SAÚDE para fins de emissão de parecer circunstanciado sobre o SHAMPOO DOCTAR PLUS e, posterior juntada da Nota Técnica 189588, na qual a conclusão foi favorável e informou que O SUS possui pomadas para uso tópico como alternativa, o corticóide DEXAMETASONA 1mg/g (Creme) (ID 161092336).

Pois bem.

No mérito, tenho que se mostra digno de acolhimento os pedidos da parte autora, pelas razões de fato e de direito a seguir vertidas. A matéria controvertida cinge-se ao direito à saúde, cuja índole é constitucional, insculpido no artigo 6º de nossa Carta Magna.

Ao Estado – em sentido amplo - cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a todos que necessitem, conforme artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que dispõem:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Mais adiante os incisos I e II do art. 198 da Constituição Federal, estabelecem;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

*II - **atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;*

O Sistema Único de Saúde – SUS é composto pela União, Estados-Membros e Municípios, sendo, pois, a responsabilidade dos entes integrantes do referido Sistema, solidária, podendo qualquer deles, isolada ou conjuntamente, ser demandado judicialmente para assegurar o direito à saúde. Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Ivo Pazolini contra a União e o Estado do Paraná, objetivando a concessão de medicamento de tratamento oncológico. RECURSO ESPECIAL DE IVO PAZOLINI 2. O STJ tem farta jurisprudência no sentido de que a lei aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe. 3. No caso concreto, a sentença que fixou a verba honorária foi publicada na vigência do CPC de 1973 (fls. 292-300, e-STJ). Desse modo, o regime aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquele previsto no art. 20 e parágrafos do CPC/1973, e não o do art. 85 do CPC/2015, que teve sua vigência iniciada apenas em 18.3.2016. Nesse sentido citam-se os EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 6.5.2019. 4. A parte recorrente se insurge contra o montante fixado a título de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, alegando: "Obtido o medicamento, o r. acórdão recorrido arbitrou o IRRISÓRIO valor de R$ 2.000,00 a título de honorários de sucumbência, a ser pago pro rata pelos Recorridos União Federal e Estado do Paraná, pois segundo o que entende o Juízo, deve ser aplicado o CPC anterior. (...) Arbitrar valor irrisório a título de honorários de sucumbência, sem qualquer parâmetro ou justificativa, se constitui, em última análise, em hierarquizar e subordinar o advogado, em relação a magistrados e membros do Ministério Público, em dissonância ao artigo recém citado. Ainda, retira do profissional o reconhecimento do caráter alimentício da referida verba e o subjuga frente aos profissionais citados, os quais deveriam tratar-se com urbanidade. Nesse

sentido, o novo Código de Processo Civil tem de ser respeitado: o valor arbitrado deve corresponder ao valor econômico da causa, o que não restou configurado no presente caso, ante a disparidade entre valor da causa (R$ 219.881,76) e o arbitrado judicialmente (R$ 2.000,00)" (fls. 530-535, e-STJ, grifos no original). 5. A Corte Especial, no julgamento dos ERESp 637.905/RS (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 21.8.2006, p. 220), firmou a compreensão de que, nas hipóteses do art. 20, § 4º, do CPC/1973, incluídas as causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será fixada mediante apreciação equitativa do magistrado, não estando adstrita aos percentuais constantes do § 3º do mesmo dispositivo legal. No juízo de equidade, porém, deve ser considerado o caso concreto, atendidas as circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do referido § 3º, podendo ser adotado, como base de cálculo, o da causa, o valor da condenação ou ser arbitrado montante fixo. 6. Por fim, é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp 1.690.266/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2018; AgInt no AREsp 1.228.581/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.3.2019. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ 7. O Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 8. Impende destacar que, conforme o entendimento do STJ, é possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito" (AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe 26/6/2015). 9. Ciente disso, assento que, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o particular detentor do direito pleiteado, não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 10. Recurso Especial de Ivo Pazolini não provido e Agravo em Recurso Especial do Estado do Paraná não provido.

(STJ - REsp: 1694759 PR 2017/0227906-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -SUNITINIBE - CARCINOMA DE CELULAS RENAIS - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. - Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar - No âmbito das Ações Civis Públicas, a liminar será deferida, com ou sem justificação prévia, a partir da demonstração dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 12 da Lei 7.347/85 c/c art. 300 do CPC)- O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a)

comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento - Demonstrado através de relatório médico e documentos juntados aos autos, que o medicamento é indispensável à saúde do paciente , de rigor o deferimento da tutela de urgência - O bloqueio de verbas públicas é um meio de compelir o Ente a tomar as medidas necessárias à garantia do direito fundamental à saúde.

(TJ-MG - AI: 17286843420238130000, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 29/09/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.RECURSO ESPECIAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR CARENTE. LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1 – Excepcionalmente o rigor do disposto no art. 2º da Lei 8.429/92 deve ser mitigado em face da possibilidade de graves danos decorrentes da demora do cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar da saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. Nos termo do art. 196 da Constituição federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso Especial desprovido.

Também o TJPE manifestou-se nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO Nº -0001495-98.2022.8.17.2220 RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO: SILVIA PATRYCIA SIQUEIRA OLIVEIRA APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. FÁRMACO OFF LABEL REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO EM LISTAGENS OFICIAIS. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 10 DIAS. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de demanda de saúde, há de se considerar a responsabilidade solidária dos Entes Federativos, nos termos do decidido pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 855.178 ED/SE (Tema nº 793). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem repisado o entendimento – com o qual esta Turma julgadora se filia - de ser prescindível o chamamento ao processo do ente da federação competente para a prestação de saúde, confirmando a tese cristalizada no REsp nº 1203244-SC, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin (Info 539). Mais que isso, aquele Tribunal entendeu que a necessidade de se identificar o ente responsável relaciona-se somente ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento àquele que indevidamente suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020). 2 A respeito da concessão de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça em sede de

recurso repetitivo firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1.657.156/RJ– Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 3. A tese firmada no supracitado repetitivo não abarca os medicamentos já incorporados ao SUS e que são por este gratuitamente fornecidos. Vale dizer, caso o medicamento esteja incorporado em listagens oficiais, é dever do Poder Público o seu fornecimento, ainda que se trate de um uso "off label". Precedente do STJ: RMS n. 66.468/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022. 4. Em casos tais, como o que ora se apresenta, sabe-se que é dever do Poder Público, previsto no art. 196[1] e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos. O fornecimento de fármacos não caracteriza tratamento privilegiado ou invasão na esfera de atos políticos da Administração, mas a mera obrigação de cumprir dever constitucional de assegurar o direito à vida. 5. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA e incorporado em listagem oficial, deve-se prezar pela indicação do profissional de saúde, o qual detém conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento e o efetivo tempo de uso no caso concreto, não cabendo ao Poder Público, com base em dados e recomendações gerais, querer desvalidar a prescrição médica. 6. Não se faz exíguo o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação. Isso porque, no caso específico dos autos, a situação de urgência apresentada não deve ceder aos entraves burocráticos da entidade estatal. Quando se trata de direito à saúde, em que há risco à integridade física e a vida, o tempo é essencial para que se possa minimizar as consequências da patologia apresentada, oferecendo o tratamento clínico indicado. 7. Remessa necessária improvida. Apelação prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA/Apelação Nº 0001495-98.2022.8.17.2220, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ESTADO DE PERNAMBUCO e SILVIA PATRYCIA SIQUEIRA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Caruaru, data na assinatura eletrônica. Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10. (TJ-PE - AC: 00014959820228172220, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO, PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE «LITISCONSÓRCIO» NECESSÁRIO ENTRE O ESTADO, A UNIÃO, O MUNICÍPIO ONDE RESIDE O IMPETRANTE E A UNIÃO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR E DA ALEGADA NEGATIVA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DO BEM TUTELADO (SAÚDE/VIDA DA IMPETRANTE) A SUPLANTAR O RIGOR FORMAL DA LEI MANDAMENTAL. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DO ART. 334, I DO CPC. ***1. O fato de o Estado integrar o SUS não lhe retira a autonomia na aplicação dos recursos repassados à saúde, pelo que não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado, a União e o Município na demanda que visa a compelir o Secretário Estadual de Saúde a fornecer medicamento de que necessita o paciente***

para a sua sobrevivência. Ademais, sendo comum o dever de prestar assistência à saúde, a obrigação é solidária, podendo ser exigida de qualquer dos entes federativos, inclusive da Unidade da Federação onde reside o impetrante da ação mandamental, sendo competente, nesse caso, a justiça estadual. 2. A instrução do mandamus com o laudo médico descritivo do tratamento que deve ser ministrado à pessoa necessitada, firmado por médica especialista, regularmente inscrita no CRM, aliada ao fato notório da negativa sistemática do Estado em fornecer o medicamento - o que enseja a aplicação do disposto no art. 334, I do CPC -, satisfaz, no caso concreto, o requisito de pré-constituição probatória inerente à ação de mandado de segurança, a par da necessidade de priorizar a vida e a saúde da impetrante em detrimento do rigor formal da lei mandamental. (Agravo Regimental 128508-1/01, Relator: Alberto Nogueira Virgínio; Órgão Julgador: 2º Grupo de Câmaras Cíveis; Data do Julgamento: 12.04.2006, Publicação 92).

Pode, pois, o Estado de Pernambuco ser demandado para assegurar o direito à saúde.

Os tribunais têm manifestado entendimento no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamentos a quem dele os necessita e não tem condições de adquiri-los.

Neste sentido os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NA LISTA OFICIAL DE DISPERSÃO GRATUITA. PREDOMINÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE. ASTREINTES. CARÁTER INIBITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A necessidade de utilização do medicamento solicitado e a inexistência de drogas similares para o combate aos efeitos da enfermidade, bem como a gravidade da doença, evidenciam a existência do dano irreparável ou de difícil reparação e a necessidade do provimento liminar. 2. A ausência do medicamento nas listagens oficiais de dispersão gratuita não deve ter o condão de afastar o direito à saúde garantido constitucionalmente. 3. A multa não é um fim em si mesmo, senão um instrumento destinado a compelir o seu destinatário ao cumprimento forçado da obrigação que lhe foi imposta. 4. Agravo improvido. (Processo: AI 3735737 PE, Relator(a): Eudes dos Prazeres França, Julgamento: 13/05/2015, Órgão Julgador: 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Publicação: 19/06/2015).

Pois bem, pelo que se vê dos autos, conforme consta do laudo médico de ID 116274521, o paciente, além de se encontrar em acompanhamento no Hospital do Câncer por Linfoma em região cervical, é portador de Dermatite Seborreica e Foliculite de Nuca – CID 10 L21.9 + L66.3.

Ainda que tais medicamentos não tenham sido incorporados à lista de medicamentos do SUS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25/04/2018, concluiu o julgamento do recurso repetitivo no REsp 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixando requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). São eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ademais, conforme em pontuado na manifestação Ministerial os três requisitos estão cumpridos nos autos, já que o laudo médico apresentado demonstra claramente que o medicamento é necessário no tratamento da paciente e, em que pese a note técnica 189588 não ser favorável, aduzindo que o shampoo doctor plus possui como alternativa no SUS Ácido Salicílico para uso tópico e o Ácido fusídico + Valerato de Betametasona possui como alternativa o corticoide Dexametasona. Ressalta-se que o parecer genérico e não vinculante foi elaborado sem exame do paciente, não sendo capaz de elidir a estratégia terapêutica traçada pelo especialista que o acompanha, de modo que, estando comprovada a necessidade de utilização contínua do medicamento, para fins de adequado tratamento médico do paciente, a obrigação de fazer deve ser imposta ao Poder Público. Assim, conforme bem pontuado pelo Parquet, é certo que deve prevalecer a prescrição médica, pois é quem teve efetivo contato com a paciente e, portanto, estava mais apto a avaliar o estado de saúde, o histórico clínico, dentre outras circunstâncias imprescindíveis à correta prescrição do tratamento médico adequado.

Portanto, evidencia-se, pois, ser imprescindível à recuperação da saúde do cidadão o fornecimento da medicação solicitada, direito este assegurado constitucionalmente.

Consoante nos ensina ALEXANDRE DE MORAES, *"a Constituição da República consagra ser a Saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)"* (*in* "Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 2ª ed. São Paulo: Atlas, p. 1926).

É válido salientar, que a demonstração da utilidade e dos efeitos práticos do tratamento ficaram evidenciados pela prescrição médica contida nos autos, sendo certo que apenas o profissional de medicina que acompanha a parte autora, com a dignidade e importância do seu trabalho, pode afirmar a eficácia real do tratamento por ele ministrado e ainda prescrever as drogas que, no seu entender, são a forma mais adequada e eficaz de combate à patologia que acomete o autor.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA LISTA PADRONIZADA DO SUS. COMPROVAÇÃO MÉDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A RECORRENTE, COM OBSERVAÇÃO QUANTO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PELO PODER PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE. PRESENÇA DOS

*REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. **1. A existência de parecer desfavorável do NAT-JUS não impede o deferimento da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, quando haja expressa recomendação médica acerca da imprescindibilidade do uso do fármaco prescrito, com registro na ANVISA, especialmente quando se demonstra que o paciente não responde satisfatoriamente ao uso das medicações ordinariamente fornecidas pelo SUS.** RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01004165020238269061 Monte Azul Paulista, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/09/2023)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004184-76.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINA PENA QUEIROZ Advogado (s): NATANNA SANTOS DE SOUZA DE ALMEIDA, DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO PRETE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. COMO MEIO ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DA AGRAVANTE. PARECER DO NATJUS. CARÁTER CONSULTIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise atenta dos autos, é possível verificar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS), órgão consultivo cujo objetivo é proporcionar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais, nas ações relacionadas com a saúde, subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidência científica, concluiu pela ausência de urgência no procedimento, tendo sido indeferida a liminar pelo juízo de origem. 2. De acordo com os relatórios médicos apresentados, elaborados por profissional médico com atuação nas áreas de cirurgia bucomaxilofacial, atesta que a cirurgia é o meio adequado para o tratamento da agravante, restando demonstrada a probabilidade de seu direito. 3. Não bastasse, em que pese o laudo confeccionado pelo NAT-JUS afirmar que se trata de procedimento eletivo, que não configura urgência e/ou emergência, conforme Resolução CFM n.º 1451/95, do Conselho Federal de Medicina, o cirurgião que acompanha a agravante pontuou o caráter de urgência para a realização da cirurgia pois o (a) paciente encontra-se severamente debilitado (a), com dor e sofrendo severas limitações de funções básicas da face como mastigação, fonação e respiração e também devido ao caráter progressivo da doença que a cada dia piora o quadro descrito, sendo certo que deve prevalecer sua prescrição, pois é quem teve efetivo contato com a paciente e, portanto, estava mais apto a avaliar o estado de saúde, o histórico clínico, dentre outras circunstâncias imprescindíveis à correta prescrição do procedimento médico adequado. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8004184-76.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante CAROLINA PENA QUEIROZ e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça JG13.

(TJ-BA - AI: 80041847620228050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. REQUISITOS NÃO EXIGÍVEIS, NO CASO CONCRETO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE O TEMA. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO, PARA ASSEGURAR A SAÚDE

DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União e do Estado do Paraná, objetivando obter o fornecimento do medicamento AFINITOR (EVEROLIMUS) 10mg, por ser portadora de câncer de mama. O acórdão do Tribunal de origem, por maioria, reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido. III. Esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ - integrado mediante Embargos de Declaração -, de relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015, firmou entendimento no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Modularam-se os efeitos do aludido Recurso Especial repetitivo, de forma que os requisitos elencados sejam exigidos, de forma cumulativa, somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 04/05/2018. IV. Na hipótese em exame, distribuído o presente feito, na instância ordinária, em 16/06/2016, descabida é a exigência da cumulatividade dos requisitos estabelecidos no aludido Recurso Especial representativo da controvérsia, aplicando-se a jurisprudência anteriormente consolidada sobre o tema, no sentido da necessidade de demonstração da imprescindibilidade do fármaco para a manutenção da saúde do paciente. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.694.975/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2019. V. O Tribunal de origem, no voto vencido do acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, notadamente da perícia judicial, concluiu que restou comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS, para o tratamento da doença que acomete a parte agravada. Segundo o entendimento expendido no referido voto, "no caso concreto, o exame do pedido se deu através de perícia médica realizada por perito especialista na matéria e nomeado pelo Juízo, indicando expressamente a necessidade do medicamento postulado para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora. (...) Extrai-se do laudo que o autor já se submeteu a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS, os quais não apresentaram eficácia, pois houve progressão da doença. (...) não há atualmente medicamento que possa substituir o tratamento com o Everolimus". Assim, demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da saúde do paciente, cabível o fornecimento do fármaco para o tratamento da mólestia que o acomete. VI. Na forma da jurisprudência do STJ, anteriormente ao entendimento firmado no Recurso Especial representativo da controvérsia sobre o tema, possível é o "fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos clínicos do SUS desde que as instâncias ordinárias atestem a imprescindibilidade do fármaco em questão" (STJ, AgInt no REsp 1.588.507/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016). VII. De qualquer sorte, infere-se, do acórdão recorrido, que, no caso concreto, encontram-se presentes as condições, estabelecidas no âmbito do Recurso Especial representativo da controvérsia, para fornecimento de medicamentos não previstos em normativos do SUS. VIII. Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). IX. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1377236 PR 2018/0261483-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAUDE. ACLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGADO PORTADOR DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA - CID 10: D 46.9, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE FLS. 18. TRATAMENTO COM AZACITIDINA (VIDAZA), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO CONSTANTE DA LISTAGEM DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBARGADO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. ALEGAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA QUAL É PORTADOR O AUTOR/EMBARGADO. FORNECIMENTO DE MARCA ESPECIFICA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS TÃO-SOMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DO CONTIDO NOS ARTS. 2º, 5º, 37, CAPUT E 37, XXI, E 196, E 198, I, TODOS DA CF/88, E ARTS. 498 E 537 DO NCPC, POREM NÃO PROVIDOS DE FORMA INDISCREPANTE.1. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula nº 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do tratamento, consistindo este tratamento em medicamento, fornecimento de mecanismos que serão implantados, ou qualquer outra forma de fármaco que venha possibilitar a cura do cidadão, razão pela qual mostra-se apropriada sua manutenção.2. Portanto, os cientistas da medicina, in casu, os médicos da autora, possuem melhores condições de indicar o tratamento adequado, sem demérito do trabalho realizado pelos consultores da Secretaria Estadual da Saúde. Ademais, não se pode correr o risco de, com a substituição de medicamentos/tratamento, ou a patologia constar ou não na lista da Portaria do Ministério da Saúde, a busca pela sobrevivência da embargada, sua reivindicação para um tratamento eficaz, seja barrada, sob a alegação de que diante da incerteza do sucesso da medicação ora indicada, a melhor medida seja a negativa. Percebe-se, sem sombra de dúvidas, que a postulação do ora agravante, visa tão somente o interesse do Estado, pretendendo menor gasto com a saúde pública em detrimento da segurança e eficácia da medicação a ser fornecida ao agravado, o que é inadmissível.3. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário.4. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.6. Aclaratórios conhecidos tão somente para fins de prequestionamento do contido nos arts. 2º (separação dos poderes), 5º, caput (princípio da isonomia), 37, caput (princípio da legalidade) e 37, XXI (exigência de licitação), e 196, caput (política pública de saúde), e 198, I, todos da CF/88, e arts. 498 e 537 do NCPC, mas nego-lhes provimento. (TJPE - Embargos de Declaração 469939-8 - 0007813-08.2015.8.17.0001-tratamento

Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - Relator(a) José Ivo de Paula Guimarães Órgão Julgador 2ª Câmara de Direito Público Data de Julgamento 17/08/2017 Data da Publicação/Fonte 29/08/2017).

III – DISPOSITIVO

POSTO ISTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e, em consequência, extingo o feito com resolução do mérito (art.487, inciso I do CPC) ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar o Estado de Pernambuco a fornecer ao Sr. ALISSON DA SILVA BEZERRA, a seguinte medicação: SHAMPOO DOCTAR PLUS 1 UNIDADE AO MÊS, E VERUTEX B CREME 1 UNIDADE ao mês, por tempo indeterminado, conforme indicação em laudo médico, sob pena de multa mensal no valor necessário à aquisição dos medicamentos, cujo montante será penhorado via SISBAJUD e entregue em favor da parte autora, condicionando as futuras e eventuais ordens de bloqueios, à apresentação de relatório e receituário médico circunstanciado que comprovem a evolução do tratamento e necessidade de continuação de uso dos medicamentos.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento na Súmula 421 do STJ, a qual preconiza que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Fica o Estado de Pernambuco dispensado do pagamento de custas e taxa processual, por se tratar de evidente hipótese de confusão patrimonial.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

A sentença está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, vez que ilíquida e proferida em desfavor do Estado de Pernambuco.

Assim sendo, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

CUMPRA-SE.

São Joaquim do Monte, datado e assinado eletronicamente.

VALDELÍCIO FRANCISCO DA SILVA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: VALDELICIO FRANCISCO DA SILVA
02/04/2024 11:11:01
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 165944417

24040211110112300000162071451

IMPRIMIR GERAR PDF